

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WILHELM-HEINRICH-KLINIK	Absaugen von beatmeten oder tracheotomierten	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

Definition

Ein Tubus und eine Trachealkanüle schränken die Reinigungsfunktion des Bronchialsystems ein. Der Patient kann das Sekret zumeist nicht vollständig abhusten, da er den zum Hustenstoß erforderlichen intrathorakalen Druck nicht aufbauen kann. Folglich ist es notwendig, das aufgestaute Sekret bei Bedarf abzusaugen.

- Auch feste oder flüssige Fremdkörper, die durch eine Aspiration in die Lufröhre gelangt sind, sollten abgesaugt werden. Wir verhindern damit eine Pneumonie.
- Die Maßnahme ist oft mit Schmerzen verbunden. Überdies wird dem Patient neben den Fremdkörpern auch die noch vorhandene Luft aus der Lunge abgesaugt. In der Folge kommt es zu Atemnot und zu Erstickungsanfällen. Daher empfinden viele Pflegebedürftige das Absaugen als bedrohlich. Demenzpatienten reagieren häufig mit Abwehrbewegungen.
- Bei einer unkomplizierten Beatmungssituation ist die offene Absaugung die beste Option. Diese Variante wird hier beschrieben. Die geschlossene Absaugung ist nur bei solchen Bewohnern notwendig, denen die temporäre Unterbrechung der Beatmung nicht zugemutet werden kann.
- Häufiges Absaugen führt zu einer Reizung der Schleimhäute. Dadurch steigt die Sekretproduktion. Es kommt daher schnell zu einem Teufelskreis aus Absaugen, der Bildung von Sekret und noch häufigerem Absaugen.

Grundsätze:

Nur ein streng aseptisches Vorgehen bietet dem Patient und den Pflegekräften Schutz vor Infektionen.

- Wir sind uns stets bewusst, dass das Absaugen für den Patient eine erhebliche körperliche und mentale Belastung ist.

Ziele:

Das Sekret wird aus den Atemwegen befördert. Eine fortschreitende Verschlechterung der Lungenfunktion als Folge der Sekretablagerung wird vermieden. Der Patient ist nach der Maßnahme in der Lage, ruhig und entspannt zu atmen.

- Wir entfernen die Fremdstoffe. Es kommt zu keiner Aspirationspneumonie.
- Wir vermeiden die Entwicklung von Atelektasen (kollabierte und funktionslose Lungenabschnitte).
- Die Schleimhaut bleibt intakt. Wir vermeiden Verletzungen.
- Der Patient versteht den Sinn und die Notwendigkeit des Absaugens.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	1	Verw./MA

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE MIT JOHANNES HARTMANNSTIFTUNG	Absaugen von beatmeten oder tracheotomierten	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

- Wir reduzieren die mentale Belastung auf ein Minimum. Der Patient erlebt kein Gefühl der Panik.
- Wir begrenzen die körperlichen Stressfaktoren. Die Sauerstoffversorgung und die Herz-Kreislauf-Funktionen werden möglichst wenig beeinträchtigt.

Vorbereitung:

Organisation

Das Absaugen ist eine ärztliche Tätigkeit, die jedoch an Pflegekräfte delegiert werden kann. Dafür ist eine schriftliche ärztliche Anordnung erforderlich. In Notsituationen dürfen Pflegekräfte auch ohne ärztliche Anordnung absaugen.

- Das Absaugen darf nur durch eine qualifizierte Pflegefachkraft erfolgen. Das korrekte Absaugen ist Teil der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Darüber hinaus wird die Durchführung regelmäßig im Rahmen von Pflegevisiten durch die Pflegedienstleitung oder durch den Praxismentor begleitet.
- Pflegekräfte dürfen Absauggeräte nur nach einer vorherigen technischen Einweisung verwenden. Dieses erfolgt durch den Praxismentor oder durch den Medizinproduktebeauftragten.
- Die Funktionsfähigkeit des Absauggeräts wird täglich geprüft. Defekte Geräte werden zeitnah ersetzt und repariert.
- Falls möglich sollte für das Absaugen eine zweite Pflegekraft bereitstehen. Diese kann das Material anreichen und gleichzeitig den Zustand des Bewohners überwachen. Ein zusätzlicher Mitarbeiter erleichtert überdies das aseptische Vorgehen. Dadurch werden gleichermaßen Pflegekräfte und Bewohner vor Infektionen geschützt.
- Bei demenziell erkrankten Senioren ist eine zusätzliche Pflegekraft von besonderer Bedeutung. Sie kann den verwirrten Bewohner beruhigen und Abwehrbewegungen verhindern.
- Manchmal ist es auch sinnvoll, Angehörige in die Maßnahme einzubinden. Diese können die Hand des Bewohners halten und ihn ablenken. Auch vermeiden wir, dass Abwehrbewegungen auftreten.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	2	Verw./MA